

GUIDA / PRESENTAZIONE

Osservazione del pasto e delle abilità alimentari

ARMONIA · OPA v1.0 · Edizione editoriale del 03/10/2026

Una raccolta strutturata per descrivere il pasto nelle sue condizioni reali: ambiente, partecipazione, alimenti, azioni visibili e informazioni della persona o di chi la assiste.

01 Per chi e in quali situazioni

Per logopedisti con competenze pertinenti all'età e alla situazione clinica, nell'ambito del lavoro del servizio e dell'équipe. La scheda può organizzare osservazioni di bambini, adolescenti e adulti durante pasti già previsti; non stabilisce aspettative uguali per tutte le età.

La versione OPA non è un protocollo per allattamento, suzione nutritiva neonatale, gestione del biberon, nutrizione enterale o somministrazione di farmaci. Questi aspetti possono essere richiamati come contesto, ma richiedono percorsi specifici.

Scheda osservativa non standardizzata — non è una diagnosi di disfagia

Non sostituisce valutazione clinica completa, valutazioni strumentali quando indicate o protocolli validati. Non attesta la sicurezza della deglutizione, non autorizza l'alimentazione orale e non prescrive consistenze, volumi, posture o manovre. Nessun punteggio, soglia o risultato automatico.

02 Come è organizzata

Guida G1–G11. Uso, limiti, spiegazioni, esempi fittizi e fonti. Leggere G3 prima dell'osservazione.

Scheda S1–S12. Contesto, panoramica, registri selezionabili e sintesi. S10 documenta eventi, interruzioni e azioni: non è una scheda di triage.

Le fonti orientano i principi generali; non validano questi campi originali. Stato editoriale e limiti della revisione: G11.

GUIDA / MODALITÀ D'USO

Osservare, non provocare una prova

Le pagine organizzano una raccolta professionale: non sono una sequenza di somministrazione.

01 Prima del pasto · S1

Definisci la domanda; consulta le indicazioni cliniche e alimentari disponibili, incluse limitazioni, allergie e assistenza prevista. Se l'alimentazione orale non è prevista, non è chiarita o vi sono nuovi dubbi clinici, non introdurre assaggi per compilare OPA: raccogli le fonti e confrontati con il referente.

02 Identifica pasto e alimenti · S1, S3

Attribuisci un codice al pasto (P01) e agli alimenti o bevande presenti (A01, A02). Mantieni preparazioni e supporti previsti, senza ampliare consistenze, porzioni o richieste per "vedere come va". La sola familiarità di un alimento non ne certifica l'appropriatezza attuale.

03 Raccogli episodi e fonti · S4–S10

Descrivi ciò che accade con attività, momento e aiuto effettivo. Un codice episodio E01 permette di richiamare la stessa evidenza. L'eventuale registrazione non equivale all'osservazione dal vivo: segnala inquadratura, audio e parti mancanti.

04 Ritorna alla panoramica · S2

Scrivi una nota nelle aree esplorate. Puoi richiamare P01/A01/E01; non devi completare tutte le aree. Un evento rilevante richiede prima l'azione appropriata, non il completamento delle caselle.

05 Concludi e condividi · S12

Riporta risorse, bisogni, limiti e domande aperte. Registra chi è stato informato, che cosa va approfondito e chi se ne occupa. Le decisioni cliniche appartengono al percorso professionale, non al risultato della scheda.

I codici sono soltanto riferimenti documentali: non sono punteggi. Per lo stesso pasto mantieni gli stessi codici anche sulle pagine duplicate. Audio/video sono facoltativi e vanno gestiti secondo le procedure del servizio, senza link pubblici nei campi.

La sicurezza viene prima della scheda

Indicazioni di prudenza per l'uso di OPA, non un algoritmo di triage o un manuale di primo soccorso.

L'assenza di tosse non esclude l'aspirazione

L'aspirazione può avvenire senza segni evidenti. Anche tosse o cambiamenti vocali, da soli, non ne dimostrano la presenza. La verifica dell'aspirazione e l'analisi della fisiologia deglutitoria richiedono approfondimenti appropriati, inclusi esami strumentali quando indicati. [1, 2]

01 Non avviare o proseguire per completare i campi

Rispetta le indicazioni vigenti e la volontà della persona. Un divieto di assunzione orale, informazioni cliniche essenziali non chiarite o condizioni nuove preoccupanti non si superano con una prova alimentare. Non somministrare acqua, nuovi cibi, quantità crescenti o consistenze diverse come verifica di sicurezza.

Se durante l'assunzione compaiono segni nuovi o preoccupanti, interrompi l'offerta e attiva il referente clinico secondo piano e procedure del servizio. Non riprendere con un altro alimento "per provare". Rifiuto o richiesta di pausa vanno rispettati: non sono automaticamente un'emergenza.

02 In caso di emergenza, agisci prima di documentare

Una difficoltà respiratoria acuta importante, un sospetto soffocamento con respiro o tosse inefficaci, alterazioni marcate del colorito o della coscienza richiedono l'attivazione immediata dei soccorsi e delle procedure di emergenza del setting. L'elenco non è esaustivo. Non attendere di compilare OPA e non usarla per decidere le manovre di soccorso. [5]

03 Registra fatti, interventi e passaggio delle informazioni · S10

Annota momento, alimento, segno concreto, cambiamento rispetto alla situazione iniziale, azioni, persone contattate e risposta ricevuta. Tosse, voce modificata, dolore, residui o affaticamento sono osservazioni da contestualizzare, non diagnosi. [1, 2]

Anche senza segni durante il campione, difficoltà persistenti riferite, riduzione dell'apporto, problemi di crescita o calo ponderale, disidratazione sospetta o episodi respiratori ricorrenti richiedono attenzione clinica appropriata. Non attendere un punteggio OPA, che non esiste. [1, 2]

GUIDA / FONTI E ALIMENTI · S1-S3

Sapere che cosa è stato osservato

Prima di descrivere un'abilità, identifica fonte, alimento e condizioni effettive.

Fonti distinte. Usa "Diretta dal vivo", "Diretta da registrazione", "Riferita dalla persona", "Riferita dal caregiver" o "Documentale". Specifica data, autore e periodo. Il resoconto di un altro pasto non diventa un evento osservato oggi.

SITUAZIONE	COME SCRIVERLA
Non esplorato	La voce non è stata indagata; puoi lasciarla vuota o dichiararlo. Non significa abilità assente.
Non osservabile	Indica perché: visibilità insufficiente, alimento non presente, interruzione o altra limitazione.
Non pertinente	La voce non riguarda la domanda o il pasto attuale; non è un livello di abilità.
Evidenza disponibile	Descrivi azione, contesto, supporti e fonte. "Non rilevato" va circoscritto a cosa e quando hai osservato.

A Descrizione di alimenti e bevande · S3

Registra denominazione, preparazione, componenti, eventuali parti solide/liquide insieme, forma e dimensioni osservate, temperatura rilevata o riferita, utensile e presentazione. "Morbido", "liquido" o "cremoso" sono descrizioni, non attestazioni di conformità o sicurezza.

Quantità. Distingui offerto, rimasto, disperso e apparentemente assunto; specifica se sono misure, stime o resoconti. La scomparsa dalla bocca o dal piatto non dimostra che tutto sia stato deglutito; non ricavare automaticamente adeguatezza nutrizionale o idrica.

IDDSI: solo un eventuale riferimento esterno documentato

OPA non applica i test IDDSI e non assegna livelli dall'aspetto del cibo. Se riporti un livello, identifica separatamente la sua fonte: piano, etichetta o verifica documentata, con data e riferimento disponibili. Il livello previsto dal piano non prova che quella preparazione sia stata verificata. Per lo standard e le risorse ufficiali, consultare IDDSI. [3]

La descrizione di una preparazione in OPA non è una ricetta, un'indicazione dietetica o un consiglio su dimensioni adatte a una persona.

Postura, ambiente e accesso al pasto

Descrivi la configurazione reale e ciò che la persona fa con i supporti disponibili.

01 Postura e setting

Che cosa osservare. Come la persona è sistemata e raggiunge cibo, bevande e interlocutori; quali elementi ambientali accompagnano l'episodio.

Che cosa annotare. Seduta, appoggi di piedi, bacino, tronco e capo per quanto visibile; tavolo, distanza dagli oggetti, illuminazione, rumore e persone presenti. Segna eventuali cambiamenti e chi li ha effettuati.

Esempio fittizio. P01: seduta abituale con appoggio del tronco; il piatto è raggiunto senza spostarlo. Dopo alcuni minuti il tronco si inclina e il caregiver interviene secondo il piano già documentato.

Limite di lettura — La scheda non identifica una postura universalmente corretta e non prescrive posizioni compensatorie. Non modificare gli appoggi soltanto per creare un confronto.

02 Autonomia, utensili e assistenza

Che cosa osservare. Azioni specifiche: prendere o tenere il contenitore, caricare l'utensile, portarlo alla bocca, scegliere, chiedere aiuto, regolare una pausa.

Che cosa annotare. Utensile abituale o adattato, azione iniziata dalla persona, preparazione dell'ambiente, aiuto verbale o fisico effettivamente fornito e risposta. Distingui scegliere da eseguire il movimento.

Esempio fittizio. La persona tiene il cucchiaino; il caregiver stabilizza il piatto. Il trasporto alla bocca è avviato dalla persona. Il supporto riguarda il piatto, non tutta la sequenza.

Limite di lettura — Non assegnare un grado globale di dipendenza. Un ausilio può consentire autonomia; la sua presenza non è un errore.

La valutazione del pasto considera anche ambiente, posizionamento e attrezzature abituali; OPA ne raccoglie soltanto una descrizione contestuale. [1, 2]

Accettazione, esplorazione e preferenze

Il pasto non è una prova di obbedienza; il contatto con il cibo non obbliga all'assunzione.

03 Accettazione ed esplorazione sensoriale

Che cosa osservare. Azioni rivolte al cibo già presente: guardare, avvicinare, toccare, annusare, assaggiare, assumere, allontanare o rifiutare. Sono possibilità descrittive, non passi obbligati.

Che cosa annotare. Alimento A__, situazione precedente, azione concreta, segnali di consenso, disagio o richiesta di pausa e risposta del partner. Distingui un'azione spontanea da una proposta.

Esempio fittizio. Davanti ad A02 la persona avvicina il piatto, tocca il bordo e poi lo allontana. Il caregiver accoglie il gesto. Nessun assaggio viene richiesto per completare la voce.

Limite di lettura — Non dedurre ipersensibilità, fobia o causa del rifiuto da un singolo episodio. Non forzare l'apertura della bocca e non usare privazioni o pressioni per ottenere un dato.

04 Repertorio e routine riferiti

Che cosa osservare. Che cosa la persona o il caregiver descrivono come abitualmente presente nei pasti, con quali preparazioni e in quali contesti.

Che cosa annotare. Periodo di riferimento, alimento e preparazione, frequenza descritta, alternative disponibili, differenze casa/scuola/servizio e vincoli medici, pratici o culturali riferiti.

Esempio fittizio. Il caregiver riferisce che negli ultimi sette giorni A01 è stato assunto a casa in una preparazione specifica; non dispone di informazioni sul pranzo scolastico.

Limite di lettura — Un pasto non rappresenta il repertorio complessivo. Il numero di alimenti non diagnostica selettività, disturbi della nutrizione o disfagia.

Descrivere il messaggio, senza attribuire intenzioni

Registra “gira il capo e dice basta” invece di “si oppone”. La letteratura professionale pediatrica invita a leggere i segnali di rifiuto anche come comunicazione e a considerare l'interazione con il caregiver. [2]

GUIDA / AZIONI ORALI VISIBILI · S6–S7

Morso, masticazione e gestione orale

La registrazione si limita a quanto realmente accessibile durante il pasto.

05 Morso e masticazione · S6

Che cosa osservare. Eventuale distacco di una porzione e movimenti visibili della mandibola durante la gestione dell'alimento previsto.

Che cosa annotare. Alimento, forma, utensile, modo di introdurre la porzione, movimenti, pause e frammenti visibili. Specifica se il morso non era richiesto, per esempio perché il cibo era già porzionato.

Esempio fittizio. A01 era già porzionato: morso non esplorato. Si osservano movimenti mandibolari alternati a pause; la lingua non è visibile nel campione.

Limite di lettura — Movimenti esterni non dimostrano triturazione completa, forza o coordinazione adeguate. Non attribuire un livello di sviluppo dalla sola forma del movimento.

06 Gestione del bolo e residui visibili · S7

Che cosa osservare. Contenimento, perdite anteriori, movimenti orali effettivamente visibili ed eventuali resti di alimento accessibili allo sguardo.

Che cosa annotare. Sede visibile, momento e alimento; eventuale espulsione, permanenza osservabile e azioni spontanee della persona. Se il cavo orale non è visibile, scrivi “non osservabile”, non “assenza di residui”.

Esempio fittizio. Dopo l'assunzione di A01 si vede un frammento sulla superficie interna del labbro inferiore. La persona lo rimuove con un movimento spontaneo; altre sedi non sono osservabili.

Limite di lettura — Non forzare l'ispezione e non introdurre dita o utensili per completare OPA. Residui orali visibili e residui faringei non sono la stessa informazione.

La fase faringea non si deduce dalla sola osservazione esterna

Questa scheda non misura il transito faringeo, non verifica la protezione delle vie aeree e non esclude residui non visibili. Un eventuale approfondimento clinico o strumentale appartiene a una valutazione appropriata, non a una conclusione automatica di OPA. [1, 2]

GUIDA / TEMPI ED EVENTI · S8, S10

Andamento, fatica e cambiamenti

Tempo misurato, impressione osservativa e sensazione riferita restano informazioni differenti.

07 Tempi del pasto e affaticamento · S8

Che cosa osservare. Sequenza delle assunzioni e delle pause, cambiamenti nei movimenti o nel coinvolgimento e richieste di interrompere.

Che cosa annotare. Inizio/fine del pasto se noti, intervallo osservato, pause e loro ragione quando disponibile. Distingui “riferisce stanchezza” da “appoggia il capo”; non chiamare automaticamente fatica ogni pausa.

Esempio fittizio. Il pasto è iniziato prima dell'arrivo del logopedista. Sono osservati 12 minuti: al nono la persona dice “sono stanco” e posa l'utensile; la richiesta di pausa viene accolta.

Limite di lettura — La durata osservata non è la durata totale. Non sono previsti tempi normativi né un numero di masticazioni da raggiungere. I conteggi sono soltanto descrittivi.

08 Eventi da documentare e azioni · S10

Che cosa osservare. Qualsiasi cambiamento rilevante: per esempio tosse, schiarimento della voce, modifica vocale, dolore riferito, vomito, perdita di alimento o alterazione dello stato generale.

Che cosa annotare. Ora o fase, cosa precede l'evento, alimento, segno concreto e fonte. Mantieni distinto ciò che è visibile da espressioni come “è andato di traverso” riferite da altri. Registra l'azione e la persona avvisata.

Esempio fittizio. Alle 12:18 compare tosse durante il pasto. L'offerta viene interrotta; viene attivato il referente del servizio. L'evento è registrato dopo avere gestito la situazione, senza ulteriori assaggi osservativi.

Limite di lettura — Non è necessario riconoscere la causa per fermare un'osservazione preoccupante. La scheda non fornisce soglie per attendere, riprovare o decidere la ripresa.

Segni isolati non confermano né escludono aspirazione. Per prudenza, indicazioni e situazioni urgenti, consultare G3. [1]

Partecipazione e strategie nel contesto

La persona e il partner fanno parte dello stesso episodio, ma le loro prospettive restano distinte.

09 Caregiver, comportamento e comunicazione · S9

Che cosa osservare. Chi propone, attende, aiuta o risponde ai segnali. Come la persona sceglie, chiede, rifiuta, segnala dolore o termina il pasto, anche senza parole.

Che cosa annotare. Segnali concreti, parole o sistemi comunicativi usati; tempi lasciati dal partner, aiuti, preferenze e carico percepito riferito dal caregiver. Descrivi fatti senza valutare la “bravura” del familiare.

Esempio fittizio. La persona indica “pausa” sulla tabella comunicativa; il caregiver interrompe la proposta e lascia l’utensile sul tavolo. Il caregiver riferisce che a scuola la tabella non è sempre disponibile.

Limite di lettura — Una preferenza o un rifiuto non dimostrano incapacità. Non interpretare difficoltà alimentari come necessariamente comportamentali: aspetti medici, nutrizionali, abilità e contesto possono interagire. [6]

10 Strategie spontanee e confronto · S9, S11

Che cosa osservare. Azioni già messe in atto dalla persona e dal partner nel piano vigente: pausa, richiesta di aiuto o altro adattamento osservato.

Che cosa annotare. Chi avvia l’azione, motivo riferito, condizioni prima/dopo e risultato visibile. Per confrontare pasti diversi conserva alimento, preparazione, utensile, momento, fonte e assistenza.

Esempio fittizio. In P01 la persona chiede al partner di stabilizzare il piatto; in P02 il piatto è già fissato. I pasti differiscono anche per durata e alimento: non attribuire la differenza a una sola variabile.

Limite di lettura — Un beneficio osservato nella partecipazione non certifica sicurezza deglutitoria e non rende una strategia una raccomandazione generalizzabile.

Decisioni complesse sull’alimentazione richiedono documentazione e confronto centrati sulla persona e sull’équipe; OPA può richiamare il piano vigente, non sostituirlo né costituire un modulo di consenso. [4]

GUIDA / ESEMPI FITTIZI

Dall'episodio alla sintesi

Esempi esclusivamente illustrativi: non sono scenari da riprodurre, prove o suggerimenti di alimenti.

A Pasto con supporti abituali

Contesto. P01, bambino durante un pasto già previsto, senza introdurre nuovi alimenti o cambiare indicazioni. In S1 sono richiamate le informazioni cliniche pertinenti; in S3 sono descritti A01 e A02, non classificati per IDDSI.

Osservazione. E01: il bambino usa l'utensile abituale; il caregiver stabilizza il piatto. E02: tocca A02, poi lo allontana e segnala "basta". La richiesta viene accolta. Il periodo osservato è di 15 minuti; il pasto era già iniziato.

Informazione riferita. Il caregiver riferisce altri alimenti assunti a casa nella settimana precedente. Non sono stati osservati e non vengono aggiunti all'inventario diretto del pasto.

Esempio di sintesi circoscritta

Nel campione P01 sono documentati iniziativa nell'uso dell'utensile e comunicazione di rifiuto con risposta del partner. Non è noto l'intero repertorio né l'andamento del pasto fuori dall'intervallo osservato. Le informazioni non attestano la sicurezza della deglutizione. Priorità: chiarire le routine nei diversi contesti con le fonti pertinenti.

B Osservazione interrotta per un cambiamento

Contesto. P02, adulto con piano alimentare del servizio già disponibile; la scheda non modifica alimenti o assistenza.

Evento e azione. E03: durante il pasto compaiono tosse e una modifica vocale percepita rispetto all'inizio. L'offerta viene interrotta e viene attivato il referente clinico. In S10 si registrano orario, fatti, azioni e risposta ricevuta. Non si propongono altri assaggi per "confermare".

Sintesi. Campione interrotto e non utilizzabile per descrivere il pasto completo. L'episodio non dimostra aspirazione e non consente di escluderla. Il seguito clinico è documentato nel percorso del servizio, non derivato dalle caselle OPA.

In entrambi gli esempi, ciò che non è stato osservato rimane non esplorato o non osservabile. La sintesi evita "mangia in sicurezza", "nessun rischio" e "dieta adeguata".

GUIDA / FONTI E STATO EDITORIALE

Riferimenti e limiti dello strumento

Fonti consultate il 03/10/2026. I richiami [1]–[6] sostengono principi generali, non validano OPA.

[1] ASHA — Adult Dysphagia

Practice Portal. Segni clinici, limiti dell'osservazione e ruolo degli approfondimenti strumentali.

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/adult-dysphagia/>

[2] ASHA — Pediatric Feeding and Swallowing

Practice Portal. Contesto del pasto, abilità, interazione con caregiver e valutazione specialistica pediatrica.

<https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/pediatric-feeding-and-swallowing/>

[3] IDDSI — Sito e risorse ufficiali

Riferimento esterno per lo standard. OPA non riproduce né applica tabelle, test o algoritmi IDDSI.

<https://www.iddsi.org/>

[4] RCSLT — Eating and drinking with acknowledged risks

Principi di decisione condivisa e documentazione multidisciplinare nell'adulto; non una procedura normativa italiana.

<https://www.rcslt.org/members/clinical-guidance/eating-and-drinking-with-acknowledged-risks-risk-feeding/>

[5] NHS — Shortness of breath

Segnali di emergenza respiratoria nell'adulto e nel bambino. I percorsi di soccorso da usare sono quelli locali.

<https://www.nhs.uk/symptoms/shortness-of-breath/>

[6] Goday PS e colleghi — Pediatric Feeding Disorder

Consensus Definition and Conceptual Framework. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019;68:124–129. DOI: 10.1097/MPG.0000000000002188.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6314510/>

OPA v1.0 — edizione editoriale, non validazione clinica

Struttura, campi ed esempi sono stati redatti per ARMONIA. Non sono state eseguite revisione clinica specialistica, sperimentazione d'uso o validazione psicometrica di questo strumento. L'edizione definitiva riguarda la redazione e l'impaginazione; non equivale a validazione, certificazione o approvazione delle fonti citate.

Prima della diffusione per uso clinico ordinario è necessaria una revisione professionale specialistica adeguata ai contesti d'impiego. Nessuna pagina OPA sostituisce protocolli validati, procedure del servizio, valutazione clinica o strumentale. Non sono riprodotti moduli o criteri diagnostici delle fonti.